Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Üst / Alt Blefaroplasti

Göz kapağı estetiği ameliyatı

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Planlanan bölge: ☐ Üst göz kapakları ☐ Alt göz kapakları ☐ Üst + alt göz kapakları

Alt kapak tekniği: ☐ Transkonjonktival ☐ Subsiliyer (kirpik altından) ☐ Uygulanmayacak _____

Ek işlemler: ☐ Yağ yeniden konumlandırma ☐ Kantopeksi / kantoplasti (kapak desteği) ☐ Yok _____

Endikasyon: ☐ Estetik ☐ Fonksiyonel (görme alanı daralması) ☐ Her ikisi _____

Hastanın şikâyeti ve beklentisi: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Yaş ilerledikçe göz kapağı derisi esneklik kaybeder, göz çevresindeki kas gevşer ve göz yuvasındaki yağ dokusu öne doğru çıkabilir. Bunun sonucunda üst kapakta **deri fazlalığı ve sarkma**, alt kapakta ise **torbalanma ve göz altı çukurlukları** oluşur. Genetik yatkınlık, güneş, sigara ve kilo değişimleri bu süreci hızlandırabilir.

Blefaroplasti, fazla deri, kas ve yağ dokusunun alınması veya yağın yeniden yerleştirilmesiyle göz çevresine **daha dinç, dinlenmiş ve doğal** bir görünüm kazandırmayı amaçlar. Üst kapak sarkması bazen görme alanının üst kısmını daraltacak kadar belirgin olabilir; bu durumda ameliyatın **görme alanını genişletme** gibi işlevsel bir amacı da vardır.

Blefaroplasti kaş düşüklüğünü, göz kapağını kaldıran kasın zayıflığına bağlı kapak düşüklüğünü (pitozis), ince kırışıklıkları (kaz ayağı) ve göz altı koyu halkalarını tek başına düzeltmez; bu durumlar için farklı tedaviler gerekebilir.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyattan önce gözleriniz muayene edilir, görme, gözyaşı ve kapak fonksiyonu değerlendirilir, fotoğraflanır. Gerekli görülürse göz hastalıkları uzmanının değerlendirmesi istenir.

1. **İşaretleme:** Alınacak deri miktarı, oturur pozisyonda ve gözler açık–kapalıyken dikkatle çizilerek belirlenir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2. **Üst kapak:** Kesi, gözü açtığınızda katlantının içinde kalacak şekilde doğal kapak çizgisine yapılır. Fazla deri, gerekirse ince bir şerit kas ve öne çıkan yağ dokusu alınır.
3. **Alt kapak – transkonjonktival teknik:** Kesi göz kapağının iç yüzünden yapılır, dışarıda iz kalmaz. Torbalanmaya yol açan yağ alınır veya göz altı çukurluğunu doldurmak üzere yeniden yerleştirilir.
4. **Alt kapak – subsiliyer teknik:** Deri fazlalığı da varsa kesi kirpiklerin hemen altından yapılır; fazla deri ve kas alınır. İz zamanla genellikle belirsizleşir.
5. **Kapak desteği (kantopeksi/kantoplasti):** Alt kapağın gevşek olduğu durumlarda, ameliyattan sonra kapağın aşağı çekilmesini önlemek için dış göz köşesine destek dikişleri konur.
6. **Kapatma:** Kesiler çok ince dikişlerle kapatılır; dikişler genellikle **5–7. günde** alınır. Göze koruyucu merhem uygulanır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Lokal anestezi (± sedasyon) veya genel anestezi	Yaklaşık 1–3 saat	Genellikle aynı gün taburculuk; genel anestezide 1 gece kalınabilir

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Göz çevresinin daha dinç, dinlenmiş ve genç görünmesi
- Üst kapakta ağırlık hissinin azalması; sarkma görme alanını daraltıyorsa görüşün rahatlaması
- Alt kapakta torbalanmanın azalması, göz altı geçişinin yumuşaması

Hastaların büyük çoğunluğu sonuçtan memnun kalır ve etki genellikle uzun yıllar sürer; ancak yaşlanma süreci devam ettiği için deri yıllar içinde yeniden gevşeyebilir. Yaklaşık 100 hastadan **2–5'inde** asimetri, yetersiz düzeltme veya iz nedeniyle küçük bir düzeltme işlemi gerekebilir. Son sonuç genellikle **3–6 ay** içinde ortaya çıkar.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Ameliyat olmamak:** Estetik bir işlem olduğu için yaptırmama seçeneğiniz her zaman vardır.
- **Göz altı dolgusu:** Hafif göz altı çukurluğunda geçici olarak kamufle edebilir; torbalanmayı ve deri fazlalığını düzeltmez, kendine özgü riskleri vardır.
- **Botoks ile kaş kaldırma:** Hafif durumlarda kaşı birkaç milimetre kaldırarak üst kapağı bir miktar açabilir; etkisi geçicidir.
- **Kaş kaldırma (temporal lift / alın germe):** Sorunun kaynağı kaş düşüklüğü ise, blefaroplasti yerine veya birlikte daha uygun olabilir.
- **Cilt yenileme uygulamaları (lazer, kimyasal peeling, radyofrekans):** İnce kırışıklıkları ve cilt kalitesini iyileştirebilir; belirgin deri fazlalığı ve torbaları gidermez.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa göz kapaklarınızın mevcut görünümü korunur ve yaşla birlikte yavaşça artabilir. Üst kapak sarkması görme alanını daraltıyorsa bu durum zamanla artabilir; ancak genellikle göz sağlığı için acil bir tehlike oluşturmaz.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri yapılır; genel anestezi veya sedasyon planlanıyorsa anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz ve önceden aç kalmanız gerekir.
- **Göz kuruluğu, glokom (göz tansiyonu), tiroid hastalığı, daha önce geçirilmiş göz ameliyatları (ör. lazerle miyopi tedavisi)** varsa mutlaka bildiriniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kontakt lens kullanıyorsanız ameliyat günü takmayınız; ameliyat sonrası gözlük kullanmanız gerekecektir.
- Ameliyat günü göz makyajı, kirpik uzatma ve yüz kremi kullanmayınız. Sedasyon veya genel anestezi sonrası eve araç kullanmadan, bir yakınınızla dönmeniz gerekir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 48 saat	Göz çevresinde şişlik, gerginlik, hafif sızıntı ve morarma olabilir. Ağrı genellikle hafiftir. Başınızı yüksekte tutarak yatmanız ve **soğuk kompres** uygulamanız şişliği azaltır. Gözlerde sulanma, ışığa hassasiyet ve geçici bulanık görme (merhem nedeniyle) olabilir.
1. hafta	Dikişler genellikle **5–7. günde** alınır. Morarma ve şişlik belirgin şekilde azalır. Göz damlası/merhem önerildiği şekilde kullanılır. Çoğu hasta 7–10 gün içinde masa başı işine ve sosyal hayata döner; morarmalar makyajla kapatılabilir.
2–4. haftalar	Kalan şişlik azalır. Kontakt lens genellikle **2 hafta** sonra kullanılabilir. Ağır egzersiz ve eğilerek yapılan işler yaklaşık 2–3 hafta ertelenir. Yüzme ve göz makyajı için hekiminizin onayını bekleyiniz.
1–6. aylar	İz kızarıklığı yavaş yavaş solar ve kapak çizgisinde belirsizleşir. Kapakların son şekli ve simetrisi genellikle **3–6 ay** içinde oturur.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Göz çevresinde şişlik ve gerginlik; morarma **olursa** 1–2 hafta içinde geçer
- Gözlerde sulanma, kuruluk hissi, batma, ışığa hassasiyet (ilk günler)
- Gözü tam kapatmada ilk günlerde hafif zorlanma
- Kesi hattında kızarıklık, hafif sertlik ve uyuşukluk

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Kuru göz** — Yaklaşık 100 hastadan **10–25'inde** batma, yanma veya kuruluk hissi olur; genellikle göz damlalarıyla birkaç hafta–birkaç ay içinde düzelir. Önceden göz kuruluğu olanlarda daha belirgin ve uzun sürebilir.
- **Gözün beyazında şişlik (kemozis)** — Göz akını örten zarın sıvı ile şişmesidir; özellikle alt kapak ameliyatından sonra görülür. Genellikle damla ve kompresle birkaç hafta içinde geçer.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Gözü tam kapatamama (lagoftalmi)** — Üst kapak ameliyatından sonra ilk haftalarda uykuda gözün tam kapanmaması sık görülür ve genellikle kendiliğinden düzelir. Bu dönemde gözün korunması için gece merhemi önerilir. Kalıcı olması nadirdir (100 hastada **1'den az**).
- **Küçük kistler (milia) ve dikiş izleri** — Kesi hattında küçük beyaz kabarcıklar oluşabilir; kendiliğinden geçer veya basit bir işlemle temizlenir.

Seyrek görülen durumlar

- **Alt kapağın aşağı çekilmesi veya dışa dönmesi (kapak retraksiyonu, ektropiyon)** — Alt kapak ameliyatından sonra yaklaşık 100 hastadan **1–5'inde** (subsiliyer teknikte daha sık) alt kapak aşağı çekilebilir, göz akı altta daha fazla görünebilir veya kapak dışa dönebilir. Çoğu masaj ve bantlama ile düzelir; kalıcı olursa gözde kuruluk ve sulanmaya yol açabilir ve **düzeltme ameliyatı** gerekebilir.
- **Asimetri ve yetersiz/aşırı düzeltme** — İki göz kapağı arasında kıvrım yüksekliği veya şekil farkı kalabilir; fazla deri alınırsa gözü kapatmada zorluk, fazla yağ alınırsa göz çukurunda çökük görünüm oluşabilir. Düzeltme işlemi gerekebilir.
- **Göz köşesinin şeklinde değişiklik** — Kapak desteği (kantopeksi/kantoplasti) uygulanan hastalarda dış göz köşesi bir süre gergin, yukarı çekik veya yuvarlak görünebilir ya da iki taraf arasında fark olabilir. Çoğu şişlik geçtikçe birkaç hafta–ay içinde yumuşar; nadiren düzeltme gerekir.
- **Kapak düşüklüğünün (pitozis) ortaya çıkması** — Önceden fazla deri nedeniyle fark edilmeyen kapak kaldırıcı kas zayıflığı ameliyattan sonra belirginleşebilir; ayrı bir ameliyatla düzeltilmesi gerekebilir.
- **Belirgin iz veya iz kalınlaşması** — Göz kapağı derisi genellikle çok iyi iyileşir; nadiren iz belirgin kalabilir, iç köşede ince bir perde (webbing) oluşabilir.
- **Kanama ve kan toplanması (hematom)** — Deri altında kan toplanması 100 hastada yaklaşık **1** oranındadır; genellikle kendiliğinden çekilir, büyükse boşaltılması gerekebilir.
- **Enfeksiyon** — Göz kapağının kanlanması çok iyi olduğundan enfeksiyon nadirdir (100 hastada **1'den az**); gelişirse antibiyotikle tedavi edilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Göz arkasında kanama ve görme kaybı** — En ciddi ancak çok nadir komplikasyondur. Göz arkasında kanama yaklaşık **2.000 hastada 1** görülür ve göz siniri üzerine baskı yapabilir. Hızla fark edilip acil müdahale edilmezse (dikişlerin açılması, kanın boşaltılması, ilaç tedavisi, acil ameliyat) **kalıcı görme kaybına** yol açabilir. Kalıcı görme kaybı yaklaşık **10.000–40.000 hastada 1** veya daha az bildirilmiştir. Bu nedenle ilk 48 saatteki uyarı belirtileri çok önemlidir.
- **Çift görme** — Alt kapak ameliyatında gözü hareket ettiren küçük bir kasın (alt oblik kas) etkilenmesine bağlıdır; çoğu zaman geçicidir, çok nadiren kalıcı olur ve ek tedavi/ameliyat gerektirebilir.
- **Kornea çiziği veya yarası** — Gözün saydam tabakasında çizik oluşabilir; ağrı, batma ve sulanma yapar, genellikle damla ile birkaç günde iyileşir. Çok nadiren uzun süreli göz tedavisi gerekebilir.
- **Gözyaşı yollarında sorun** — Gözyaşı kanalının etkilenmesine bağlı sulanma çok nadirdir.
- **Psikolojik memnuniyetsizlik** — Teknik olarak başarılı bir sonuca rağmen kişi yeni görünümüne uyum sağlamakta zorlanabilir. Beklentilerin ameliyat öncesi açıkça konuşulması bu riski azaltır.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- **Gözde şiddetli, giderek artan ağrı**, özellikle tek tarafta
- **Gözün öne doğru fırlaması**, göz kapaklarında hızla artan, gergin şişlik ve morarma
- **Görmede azalma**, görmenin kararması, çift görme veya göz hareketlerinde kısıtlılık
- Bulantı-kusma ile birlikte göz ağrısı
- **38,5 °C üzerinde ateş**, kesi yerinde artan kızarıklık, akıntı veya ağrı
- Gözde ışığa aşırı hassasiyet ve geçmeyen batma
- **İlk 48 saatte bu belirtilerden biri olursa dakikalar önemlidir; hemen arayınız veya en yakın acil servise gidiniz.**

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 48 saat düzenli aralıklarla soğuk kompres uygulayınız; başınızı yüksekte tutarak sırtüstü yatınız.
- Gözlerinizi ovuşturmayınız. İlk günlerde ağır kaldırmak, eğilmek, ıkınmak ve kanama riskini artıran aktivitelerden kaçınınız.
- Size verilen göz damlası ve merhemleri önerilen sıklıkta kullanınız; gözler tam kapanmıyorsa gece merhemi mutlaka sürünüz.
- Kontakt lensleri genellikle 2 hafta, göz makyajını 1–2 hafta kullanmayınız. Dışarıda güneş gözlüğü takınız; ekran başında sık ara veriniz.
- Yurt dışından geldiyseniz uçak yolculuğu genellikle dikişler alındıktan sonra (5–7. gün) güvenlidir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa “yoktur” yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Blefaroplastinin kaş düşüklüğünü, kapak kaldırıcı kas zayıflığına bağlı kapak düşüklüğünü, ince kırışıklıkları ve göz altı renk koyuluğunu tek başına düzeltmediğini anladım.
- ☐ Ameliyattan sonraki ilk 48 saatte gözde şiddetli ağrı, şişlik veya görmede azalma olursa **hemen** başvurmam gerektiğini biliyorum.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.